

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

iguratimod 25mg

(콜벳정 25밀리그램, 동아에스티(주))

- ☐ 제형, 성분·함량 :
 - 1정 중 iguratimod 25mg
- ☐ 효능 효과 :
 - 만성 류마티스 관절염
- ☐ 약제급여평가위원회 심의일
 - 2015년 제8차 약제급여평가위원회 : 2015년 7월 9일
 - 급여기준자문위원회 심의일 : 2015년 5월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “만성 류마티스 관절염”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 상대적 임상적 유용성을 입증하는 근거가 부족하고, 소요비용이 대체 약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “만성 류마티스 관절염”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제 sulfasalazine, hydroxychloroquine, methotrexate, bucillamine, penicillamine이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 In vitro 연구에서 사람의 단핵구와 활막세포에 의해 생성되는 IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-17, TNF- α 생성을 줄이며, B림프구의 증식에 영향을 주지 않으면서 B림프구에 직접 작용하여 immunoglobulin의 생산을 억제함. 또한 자가면역 동물 모형에서 스테로이드와 유사한 개선효과를 보였으며, osterix의 발현을 증가시켜 뼈의 붕괴를 막고 뼈 대사 동화작용을 보임.¹⁾
- 신청품은 교과서에 수록되어 있지 않으며, 일본 임상진료지침에서 류마티스관절염 환자에 대한 치료제로 권고하고 있으나, 장기 안전성이 확인되지 않아 약한 강도로 추천함.²⁾

[대체 약제 대조 임상시험]

- active RA로 진단된 환자(n=489)를 대상으로 iguratimod 1군(첫 4주간 iguratimod 25mg/일, 이후 20주간 50mg/일, 허가사항에 해당함), iguratimod 2군(iguratimod 50mg/일), MTX군을 1:1:1 무작위 배정한 24주 임상연구 결과, MTX군은 iguratimod 1군보다 유의하게 ACR20이 높았고(p=0.0414), iguratimod 2군과 MTX군의 ACR20 반응률은 유의한 차이가 없었고 비열등성을 입증함(63.8% vs 62.0%, p=0.7257).³⁾

- active RA로 진단된 20세 이상의 환자(n=376)를 대상으로 iguratimod군, salazosulfapyridine군, 위약군에 2:2:1 무작위 배정하여 28주간 임상연구를 함. 우월성 분석시 ACR20은 위약군보다 iguratimod군에서 유의하게 높았고(53.8% vs 17.2%, $p<0.001$), 비열등성 분석시 iguratimod군(63.1%)은 salazosulfapyridine군(57.7%) 대비 ACR20에 대한 비열등성을 입증함.⁴⁾

[단독투여 위약 대조 임상시험]

- active RA로 진단된 환자(n=280)에서 iguratimod 25mg/일, iguratimod 50mg/일, 위약에 대하여 1:1:1 무작위 배정하여 24주간 임상시험 한 결과, 시간 경과에 따라 위약군에 비하여 iguratimod 치료군에서 유의하게 높은 ACR 반응률을 보임.⁵⁾

[Methotrexate 병용투여 위약 대조 임상시험]

- MTX 단독 투여에 충분히 반응하지 않는 active RA 환자(n=253)에서 iguratimod군(iguratimod+MTX), 위약군(위약+MTX)으로 2:1 무작위 배정하여 임상 시험한 결과, 24주에 위약군 대비 iguratimod군에서 ACR20이 유의하게 높았음(30.7% vs 69.5%, $p<0.001$).⁶⁾
- 이후에 iguratimod와 MTX 병용 요법의 추가적인 안전성 및 유효성을 알아보기 위한 24주 연장시험에서 기존 iguratimod군과 위약군(이하 위약/iguratimod군) 모두 iguratimod를 투여 받음.⁷⁾
 - iguratimod군의 ACR20은 24주와 52주에 유사하였고, ACR50, ACR70 모두 52주, 24주 간에 유의한 차이가 있었음(각각 $p=0.003$, $p=0.048$).
 - 위약/iguratimod군에서 ACR20은 24주에 비하여 52주에 유의하게 높았고($p<0.001$), ACR50, ACR70 모두 52주와 24주에 유의한 차이가 있었음($p<0.001$). 52주의 ACR20, ACR50, ACR70은 iguratimod군과 위약/iguratimod군 간에 유의한 차이가 없었음.

[단일군 장기 임상시험]

- active RA로 진단된 20세 이상 환자(n=394)에서 iguratimod의 장기 안전성을 평가하기 위한 52주(일부 환자에서 100주) 임상시험 결과, adverse events는 52주 97.6%, 100주 97.6%이었으며, adverse reaction은 52주 61.8%, 100주 65.3%이었음.⁸⁾⁹⁾
- 학회의견¹⁰⁾에 따르면, 임상시험이 일부 국가에 국한되어 수행되었고, 장기간 임상연구 결과가 미비하여 약제의 장기간 투여에 따른 효능 및 안전성에 대해 확신을 가지기 어렵고, 신청품 투여에 따른 방사선학적 관절손상의 예방 혹은 억제

효과가 보고된 바가 없으므로 효과에 대한 근거가 부족함.

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 약제인 sulfasalazine, methotrexate, hydroxychloroquine, bucillamine, penicillamine를 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품은 대체약제 중 sulfasalazine 대비 유효성(ACR20)에서 비열등함을 입증하였으나, methotrexate 대비 유의하게 열등하였음.¹¹⁾
- 신청품의 1일 투약비용 ■■■원은 대체약제 1일 투약비용인 ■■■원 대비 고가임

○ 재정 영향¹²⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수¹³⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제시 예상 사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체 약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가할 것으로 예상됨¹⁵⁾¹⁶⁾

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) Lu LJ. Multicenter, randomized, double-blind, controlled trial of treatment of active rheumatoid arthritis with T-614 compared with methotrexate, Arthritis&rheumatism. 2009;61(7):979
- 2) Guidelines for the management of rheumatoid arthritis, Japan College of Rheumatology 2014
- 3) Lu LJ et al. Multicenter, randomized, double-blind, controlled trial of treatment of active rheumatoid arthritis with T-614 compared with Methotrexate. Arthritis Rheum. 2009;61(7):979-87
- 4) Hara M et al. Efficacy and safety of iguratimod compared with placebo and salazosulfapyridine in active rheumatoid arthritis: a controlled, multicenter, double-blind, parallel-group study. Mod Rheumatol. 2007;17:1-9
- 5) Lu LJ et al. Safety and efficacy of T-614 in the treatment of patients with active rheumatoid arthritis: a double blind, randomized, placebo-controlled and multicenter trial. Chin Med J. 2008;121(7):615-9
- 6) Ishiguro N et al. Mod Rheumatol. Concomitant iguratimod therapy in patients with active rheumatoid arthritis despite stable doses of methotrexate: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 2013;23(3):430-9
- 7) Hara M et al. Mod Rheumatol. Safety and efficacy of combination therapy of iguratimod with methotrexate for patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to methotrexate: an open-label extension of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 2014 May;24(3):410-8.
- 8) adverse events는 실험실 수치의 비정상적 변화 등을 포함하여 나타나는 좋지 않은 증상 및 소견, adverse reaction은 실험 약물과 관련 있는 adverse events으로 정의함
- 9) Hara M et al. Long-term safety study of iguratimod in patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2007;17(1):10-6
- 10) [REDACTED]
- 11) 신청품 허가 용량 기준
- 12) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 13) 2014년도 EDI상 [REDACTED] 상병 환자수 중 현재 등재되어 있는 sulfasalazine, hydroxychloroquine, methotrexate, bucillamine을 청구한 환자수
- 14) IMS data에 근거하여 sulfasalazine, leflunomide, bucillamine을 투여하는 환자수 중 신청품 예상 점유율(1차년도 [REDACTED]%, 2차년도 [REDACTED]%, 3차년도 [REDACTED]%)을 반영하여 신청품의 예상 환자수(1차년도 [REDACTED]명, 2차년도 [REDACTED]명, 3차년도 [REDACTED]명)를 산출하고 이에 따라 예상사용량(1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED], 3차년도: [REDACTED])을 산출함.
- 15) 직전년도의 대체약제 간 청구 비중이 신청품 등재전후의 청구 비중과 동일하다고 가정함
- 16) 재정증감액 = (신청품 일일투약비용 - 대체약제 일일투약비용) × 제약사 제시 예상사용량